AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3

TOMO 06 · DM · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

DIABETES MELLITUS

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

24	11	4
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 1 · Medicina Interna · complemento visual del Tomo 06

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 06 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 16

Índice por tipo de imagen 19

Soluciones de la autoevaluación 22

Signos con nombre propio 18

Autoevaluación 20

01 Diagnóstico, Clasificación y Tamizaje de Diabetes

1.1 Tipos de Diabetes Mellitus

01 Acantosis nigricans en el cuello 3

1.2 Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS

02 Acantosis nigricans axilar 3

02 Farmacoterapia Oral y Manejo de DM2 en APS

2.3 Nuevas Terapias

03 Candidiasis vulvovaginal 4

03 Insulinoterapia y Manejo Hospitalario

3.1 Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio

04 Lipohipertrofia por insulina 4

04 Emergencias Hiperglicémicas Agudas

4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato

05 Hipokalemia en la cetoacidosis: onda U 5

06 Hiperkalemia en la cetoacidosis: T picudas 6

05 Complicaciones Crónicas y Dislipidemias

5.1 Nefropatía Diabética

07 Glomeruloesclerosis nodular (Kimmelstiel-Wilson) 7

5.2 Retinopatía Diabética

08 Hemorragias en punto y exudados duros 7

09 Retinopatía diabética: microaneurismas 8

10 Exudados algodonosos y hemorragias 8

11 Retinopatía proliferativa: neovasos en la papila 9

5.3 Pie Diabético

12 Pie neuropático con dedos en garra 9

13 Monofilamento de 10 g 10

14 Úlcera neuropática (mal perforante plantar) 10

15 Úlcera isquémica distal 11

16 Osteomielitis en resonancia 11

17 Índice tobillo-brazo 12

5.4 Dislipidemias

18 Xantelasmas 12

19 Xantoma tendinoso del Aquiles 13

5.5 Dislipidemias Severas y Genéticas

20 Plasma lipémico 13

21 Xantomas eruptivos 14

22 Arco corneal 14

5.6 Nutrición Clínica

23 Manga gástrica 15

24 Acantosis nigricans (síndrome metabólico) 15

01 TEMA 1.1 · TIPOS DE DIABETES MELLITUS

FOTO CLÍNICA



Imagen: High-Yield review, p. 774

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pliegues hiperpigmentados y aterciopelados

DIAGNÓSTICO

Acantosis nigricans en el cuello

Piel oscura, engrosada y aterciopelada: signo de resistencia a la insulina.

CONDUCTA INICIAL

Orienta a DM tipo 2: glicemia de ayuno, HbA1c o PTGO.

1.02.1.005	Diabetes mellitus tipo 2	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
1.02.1.016	Síndrome metabólico	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Suciedad: se quita al lavar.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P42 «Un paciente de 30 años, con IMC: 30 Kg/m2 consulta por hoperpigmentación de la piel de las axilas y el cuello, asociado a aparición de...» → **Resistencia a la insulina**

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 7
Tema 1.1

Clase 1.1 en video

02 TEMA 1.2 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DIABETES MELLITUS, PREDIABETES Y TAMIZAJE EN APS

FOTO CLÍNICA

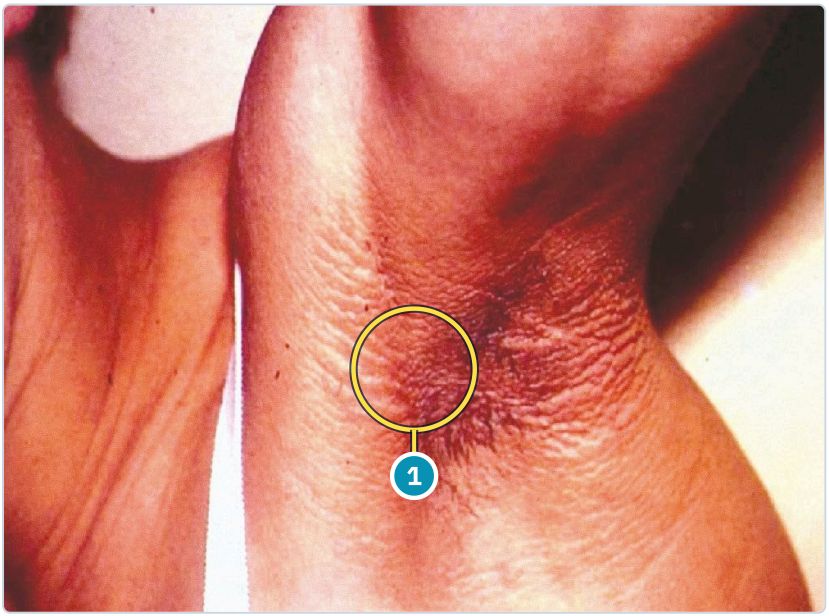


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 30

QUÉ TIENES QUE VER

1 Piel axilar oscura y engrosada

DIAGNÓSTICO

Acantosis nigricans axilar

Hiperpigmentación aterciopelada de las axilas y pliegues.

CONDUCTA INICIAL

HOMA-IR > 2,6 certifica resistencia a la insulina; obeso con glicemia normal: dieta y ejercicio.

1.02.1.016	Síndrome metabólico	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hiperpigmentación postinflamatoria.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 10
Tema 1.2

Clase 1.2 en video

03 TEMA 2.3 · NUEVAS TERAPIAS

FOTO CLÍNICA

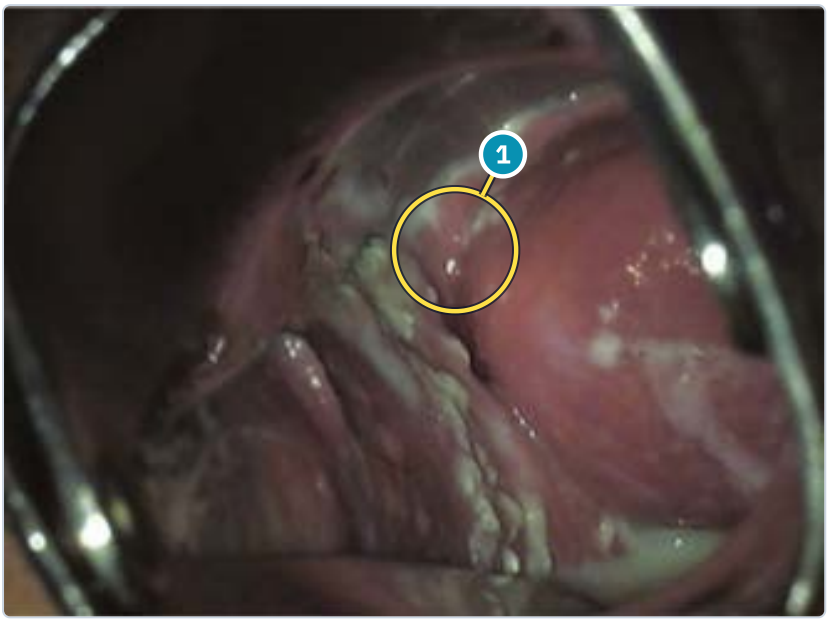


Imagen: Kumar and Clark, Clinical Medicine, p. 1587

QUÉ TIENES QUE VER

1 Placas blanquecinas en la mucosa

DIAGNÓSTICO

Candidiasis vulvovaginal

Placas blanquecinas sobre la mucosa enrojecida: efecto adverso de los iSGLT2.

CONDUCTA INICIAL

Efecto adverso más frecuente de los iSGLT2; ojo con la cetoacidosis euglicémica.

1.02.1.005 Diabetes mellitus tipo 2
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Vaginosis bacteriana: flujo gris sin placas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 34
Tema 2.3

Clase 2.3 en video

04 TEMA 3.1 · TIPOS DE INSULINA, FARMACOCINÉTICA E INDICACIONES DE INICIO

FOTO CLÍNICA

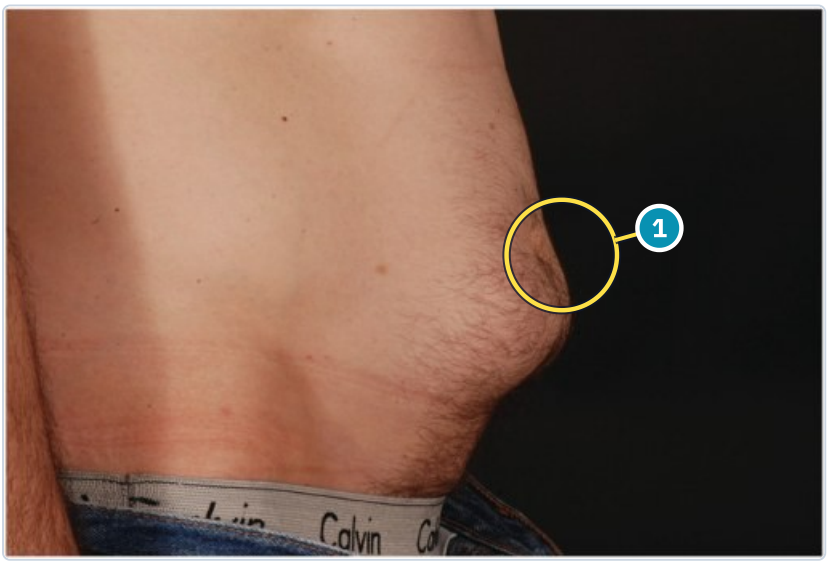


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Abultamiento en el sitio de inyección

DIAGNÓSTICO

Lipohipertrofia por insulina

Abultamiento de grasa fibrosa donde el paciente pincha siempre.

CONDUCTA INICIAL

Rotar los sitios: la absorción errática da hiperglicemias inexplicables.

1.02.1.005 Diabetes mellitus tipo 2
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

1.02.1.004 Diabetes Mellitus tipo 1
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hernia de pared: protruye con Valsalva.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P17** «Un paciente de 12 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de NPH matinal, despierta con glicemias de ayuno muy elevadas, asociadas a…» → **Dejar dos dosis de insulina…**

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 44
Tema 3.1

Clase 3.1 en video

05 TEMA 4.3 · INSULINOTERAPIA ENDOVENOSA Y MANEJO DEL POTASIO Y BICARBONATO — TRAZADO (ECG / REGISTRO)

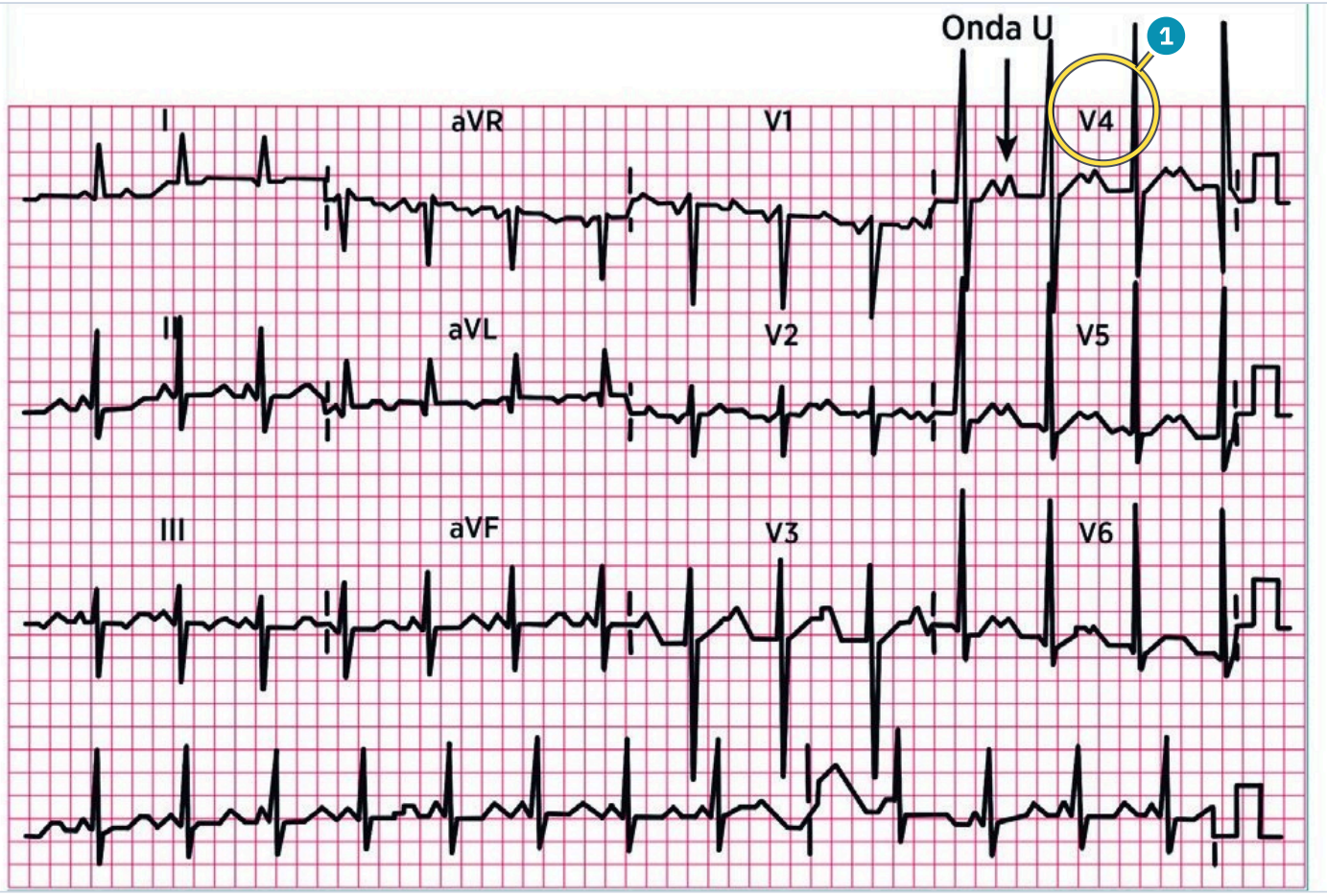


Imagen: Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 22

QUÉ TIENES QUE VER

1 Onda U (flecha)

DIAGNÓSTICO

Hipokalemia en la cetoacidosis: onda U

T aplanada, ST descendido y onda U prominente tras la T.

CONDUCTA INICIAL

K < 3,3: la insulina está contraindicada hasta reponer potasio; entre 3,3 y 5,2, agregar 20-30 mEq de KCl por litro.

1.02.2.002 Cetoacidosis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

1.09.2.006 Hipokalemia — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hiperkalemia: T picudas.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P101** «Adulto con cetoacidosis diabética, pH 7,1 y potasio plasmático de 3,0 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial?» → **Hidratar con suero fisiológico y reponer potasio antes de iniciar**…

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS p. 70 Tema 4.3

Clase 4.3 en video

06 TEMA 4.3 · INSULINOTERAPIA ENDOVENOSA Y MANEJO DEL POTASIO Y BICARBONATO

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

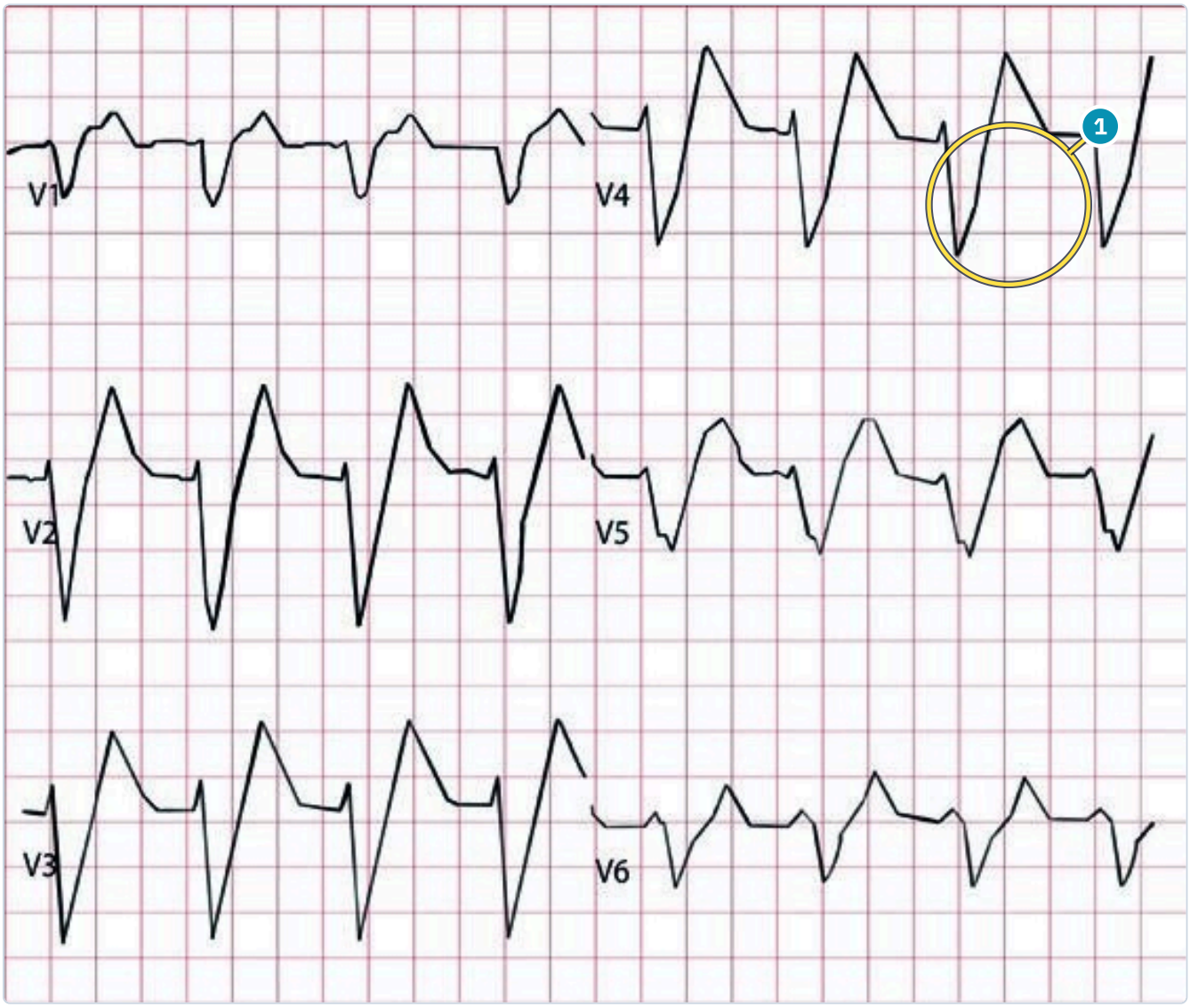


Imagen: Manual CTO Cardiología 14.ª ed., p. 19

QUÉ TIENES QUE VER

1 T altas y picudas en las precordiales

DIAGNÓSTICO

Hiperkalemia en la cetoacidosis: T picudas

Sobre 5,5 mEq/L, lo primero son T altas, picudas y simétricas de base angosta.

CONDUCTA INICIAL

ECG al ingreso y monitoreo mientras el potasio esté alterado.

1.02.2.002 Cetoacidosis
Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

1.02.4.009 Electrocardiograma — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hipokalemia: T aplanada y onda U.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2024 · P101 «Adulto con cetoacidosis diabética, pH 7,1 y potasio plasmático de 3,0 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial?» → **Hidratar con suero fisiológico y reponer potasio antes de iniciar…**

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 70
Tema 4.3

Clase 4.3 en video

07 TEMA 5.1 · NEFROPATÍA DIABÉTICA

ESQUEMA

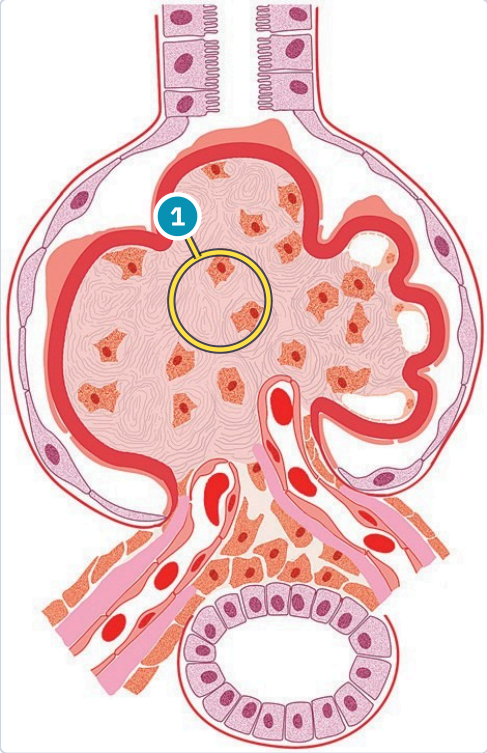


Imagen: Goljan, Rapid Review Pathology, Link 20-48

QUÉ TIENES QUE VER

1. Nódulos mesangiales

DIAGNÓSTICO

Glomeruloesclerosis nodular (Kimmelstiel-Wilson)

Nódulos de matriz en el mesangio que ocupan el ovillo glomerular.

CONDUCTA INICIAL

Tamizaje anual con RAC; microalbuminuria persistente: IECA o ARA-II aunque sea normotenso.

1.09.1.014	Nefropatía diabética	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo
1.02.1.010	Nefropatía incipiente	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Nefroangioesclerosis hipertensiva.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P76 «Un paciente de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control, refiere estar asintomático....» → **Iniciar enalapril**

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 85
Tema 5.1

Clase 5.1 en video

08 TEMA 5.2 · RETINOPATÍA DIABÉTICA

FONDO DE OJO

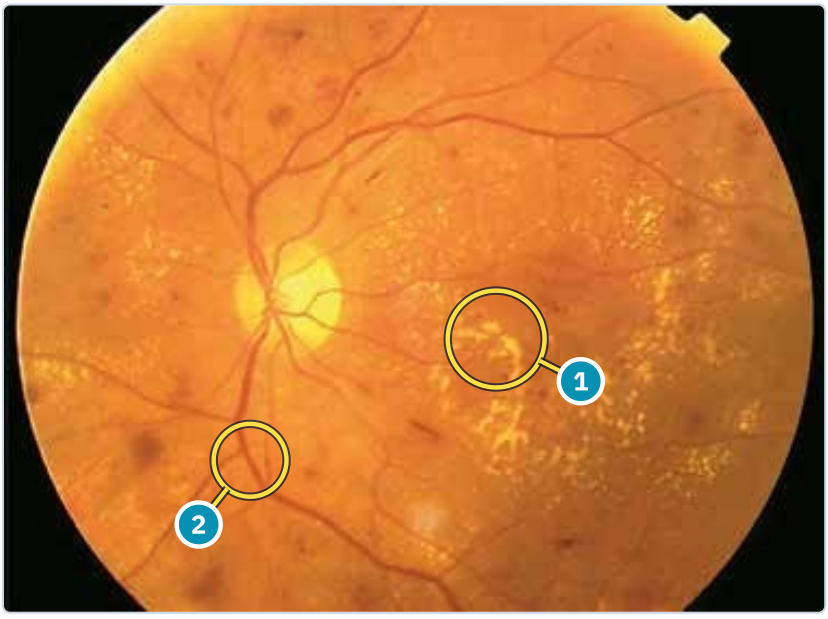


Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 67

QUÉ TIENES QUE VER

1. Exudados duros amarillos
2. Hemorragias en punto

DIAGNÓSTICO

Hemorragias en punto y exudados duros

Fuga de lípidos y sangre de un capilar dañado.

CONDUCTA INICIAL

No proliferativa: control metabólico y seguimiento oftalmológico.

1.02.1.015	Retinopatía diabética	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Exudados algodonosos: blancos, de bordes borrosos (isquemia).

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 88
Tema 5.2

Clase 5.2 en video

09 TEMA 5.2 · RETINOPATÍA DIABÉTICA

FONDO DE OJO

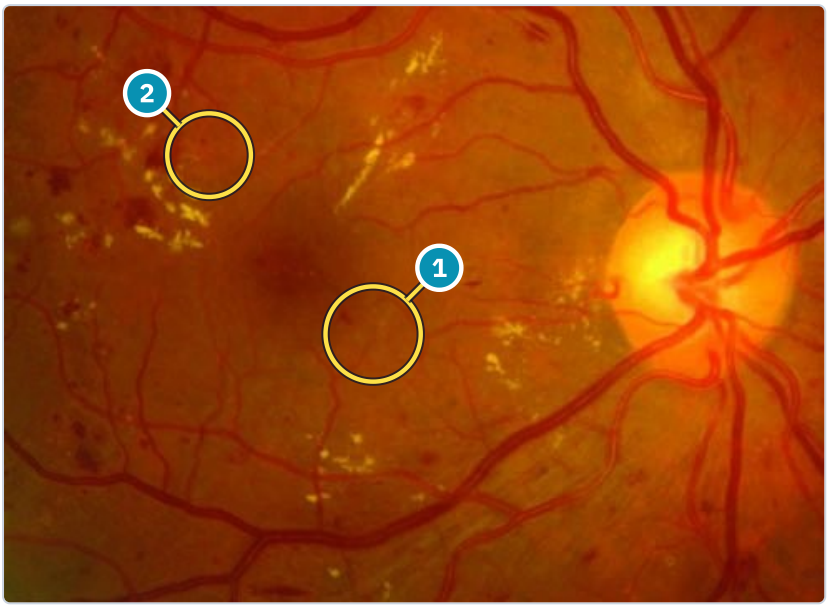


Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 537

QUÉ TIENES QUE VER

1. Microaneurismas
2. Exudados duros

DIAGNÓSTICO

Retinopatía diabética: microaneurismas

Puntitos rojos: la lesión más precoz de la retinopatía diabética.

CONDUCTA INICIAL

Fondo de ojo al diagnóstico de la DM2 y anual.

`1.02.1.015` **Retinopatía diabética**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.02.5.003` **Fondo de ojo**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Retinopatía hipertensiva: cruces AV y hemorragias en llama.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 88
Tema 5.2

Clase 5.2 en video

10 TEMA 5.2 · RETINOPATÍA DIABÉTICA

FONDO DE OJO

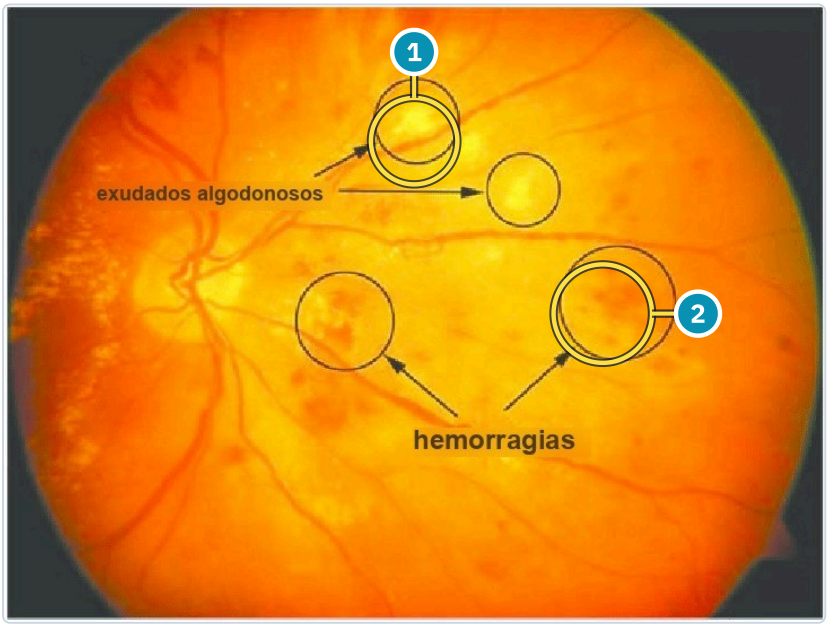


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1. Exudados algodonosos
2. Hemorragias

DIAGNÓSTICO

Exudados algodonosos y hemorragias

Manchas blancas de bordes borrosos (microinfartos) rodeadas de hemorragias.

CONDUCTA INICIAL

Retinopatía no proliferativa: control metabólico y control oftalmológico.

`1.02.1.015` **Retinopatía diabética**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Exudados duros: amarillos, brillantes, de bordes netos (fuga de lípidos).

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 88
Tema 5.2

Clase 5.2 en video

11 TEMA 5.2 · RETINOPATÍA DIABÉTICA

FONDO DE OJO



Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8th ed., p. 542

QUÉ TIENES QUE VER

1 Neovasos en abanico

DIAGNÓSTICO

Retinopatía proliferativa: neovasos en la papila

Vasos finos y desordenados que salen de la papila en abanico.

CONDUCTA INICIAL

Panfotocoagulación con láser (GES).

1.02.1.015	Retinopatía diabética	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.02.1.023	Retinopatía diabética	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Vasos normales: ramificación ordenada.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P124** «Mujer de 58 años con diabetes tipo 2 y buen control metabólico (HbA1c 6,8%) en cuyo fondo de ojo se observa retinopatía diabética proliferativa....» → **Derivar a oftalmología para**...

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS **p. 88** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

12 TEMA 5.3 · PIE DIABÉTICO

FOTO CLÍNICA

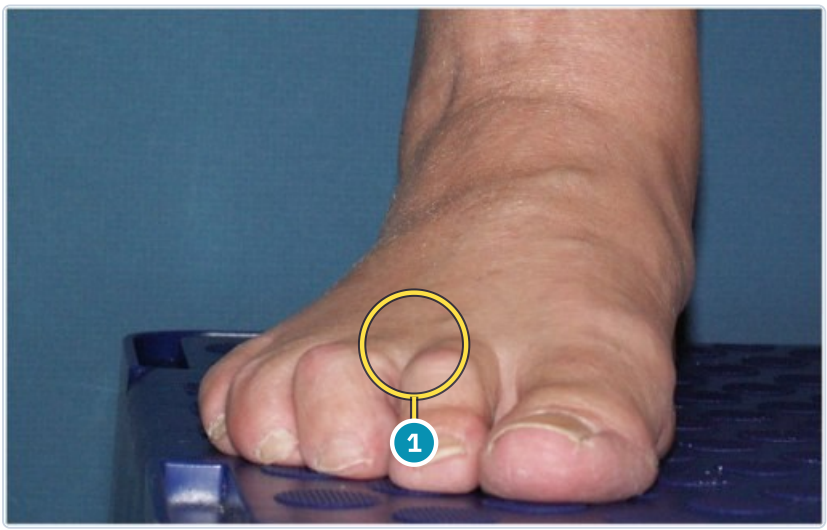


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Dedos en garra

DIAGNÓSTICO

Pie neuropático con dedos en garra

Atrofia intrínseca: dedos en garra y cabezas metatarsianas prominentes.

CONDUCTA INICIAL

Calzado adecuado y control podológico.

1.02.1.011	Neuropatía diabética	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.02.1.014	Pié diabético y otras infecciones en diabetes	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hallux valgus aislado.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P93** «DM con polineuropatía, dedos en garra, hiperqueratosis, con test de monofilamento alterado, pulsos disminuidos, conducta:» → **Mejorar calzado**

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS **p. 92** Tema 5.3

Clase 5.3 en video

13 TEMA 5.3 · PIE DIABÉTICO

OTRA (AGENTE O VECTOR)

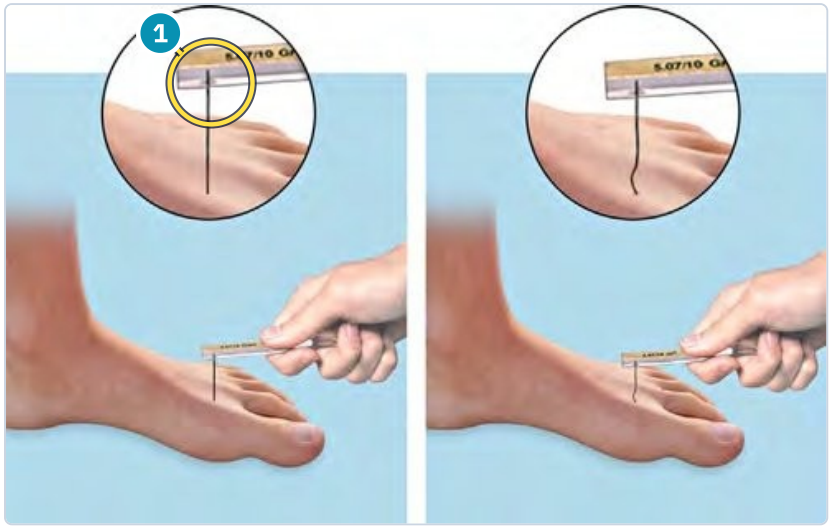


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. El filamento se dobla al apoyarlo

DIAGNÓSTICO

Monofilamento de 10 g

Se apoya en la planta hasta que se dobla.

CONDUCTA INICIAL

Un solo punto no percibido = pie de alto riesgo de ulceración.

1.02.1.011	Neuropatía diabética	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.02.3.009	Prevención de pié diabético	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Diapasón: evalúa vibración.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 91
Tema 5.3

Clase 5.3 en video

14 TEMA 5.3 · PIE DIABÉTICO

FOTO CLÍNICA

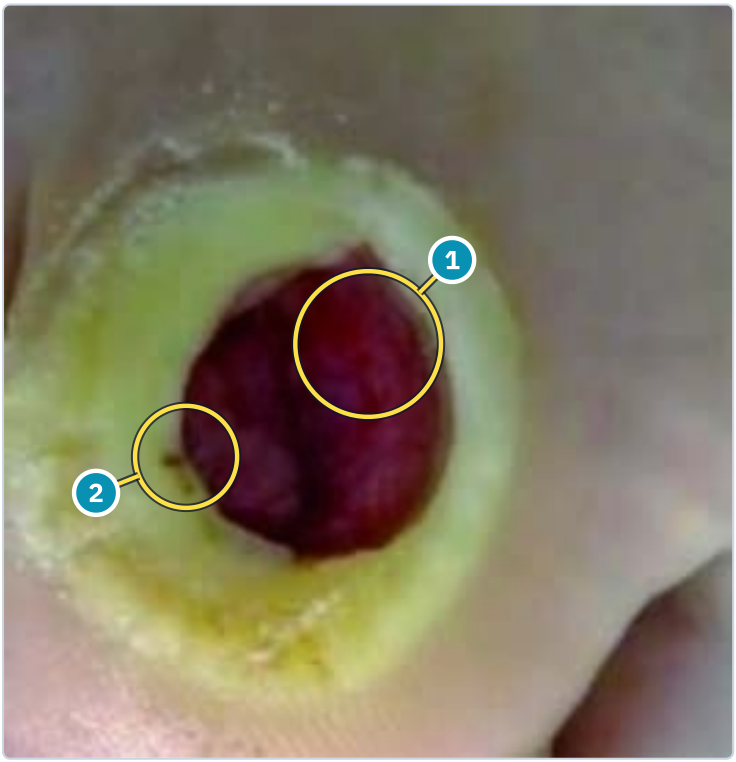


Imagen: Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 114

QUÉ TIENES QUE VER

1. Lecho de la úlcera
2. Rodete hiperqueratósico

DIAGNÓSTICO

Úlcera neuropática (mal perforante plantar)

Indolora, en zona de apoyo, rodeada de un rodete de callo.

CONDUCTA INICIAL

Descarga de presión (off-loading) y curación avanzada.

1.02.1.014	Pié diabético y otras infecciones en diabetes	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.051	Pie diabético	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Úlcera isquémica: distal, pálida, sin callo.

PREGUNTA REAL — **Julio 2013 · P143** «Un paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, presenta desde hace unas semanas úlcera en zona plantar…» → **Antibióticos endovenosos y…**

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 92
Tema 5.3

Clase 5.3 en video

15 TEMA 5.3 · PIE DIABÉTICO

FOTO CLÍNICA

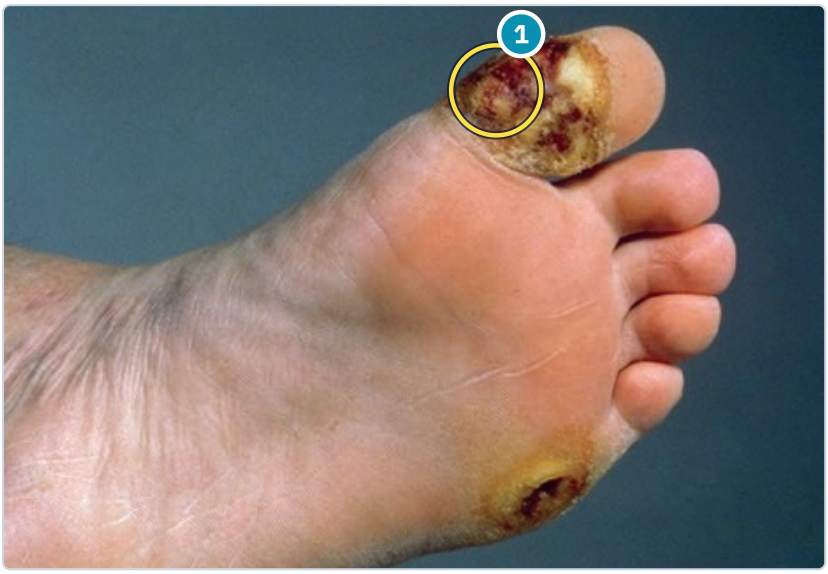


Imagen: Talley and O'Connor Clinical Examination, p. 142

QUÉ TIENES QUE VER

1 Necrosis en la punta del dedo

DIAGNÓSTICO

Úlcera isquémica distal

En la punta del dedo, lecho pálido o necrótico y sin callo.

CONDUCTA INICIAL

Estudiar la irrigación (ITB, eco-Doppler) antes de resecar.

4.01.1.047	Insuficiencia arterial crónica	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
1.02.1.019	Vasculopatía periférica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Úlcera neuropática: en zona de apoyo.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P146 «Diabético fumador con dolor en pantorrillas al caminar 120 metros, ausencia de reflejos patelares, hipoestesia y pulsos pedios débiles. ¿Cuál es…» → **Índice tobillo-brazo (ITB)**

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 94
Tema 5.3

Clase 5.3 en video

16 TEMA 5.3 · PIE DIABÉTICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

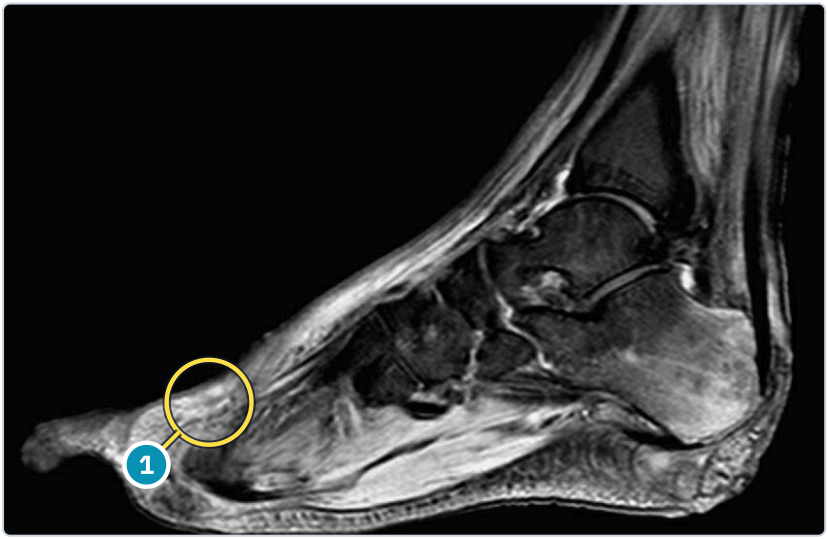


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 522

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hueso con señal alterada

DIAGNÓSTICO

Osteomielitis en resonancia

El hueso bajo la úlcera cambia de señal.

CONDUCTA INICIAL

Estilete óseo positivo = Wagner 3: hospitalizar, desbridar y antibióticos.

1.02.1.014	Pié diabético y otras infecciones en diabetes	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.051	Pie diabético	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pie de Charcot: sin úlcera ni fiebre.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 94
Tema 5.3

Clase 5.3 en video

17 TEMA 5.3 · PIE DIABÉTICO

OTRA (AGENTE O VECTOR)



Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 966

QUÉ TIENES QUE VER

1 Doppler sobre la arteria del tobillo

DIAGNÓSTICO

Índice tobillo-brazo

Presión sistólica del tobillo dividida por la del brazo, con Doppler manual.

CONDUCTA INICIAL

Claudicación en diabético fumador: ITB.

4.01.1.047 **Insuficiencia arterial crónica**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.02.4.008 **Doppler vascular periférico**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Calcificación arterial: ITB falsamente alto.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P146 «Diabético fumador con dolor en pantorrillas al caminar 120 metros, ausencia de reflejos patelares, hipoestesia y pulsos pedios débiles. ¿Cuál es…» → **Índice tobillo-brazo (ITB)**

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 91
Tema 5.3

Clase 5.3 en video

18 TEMA 5.4 · DISLIPIDEMIAS

FOTO CLÍNICA

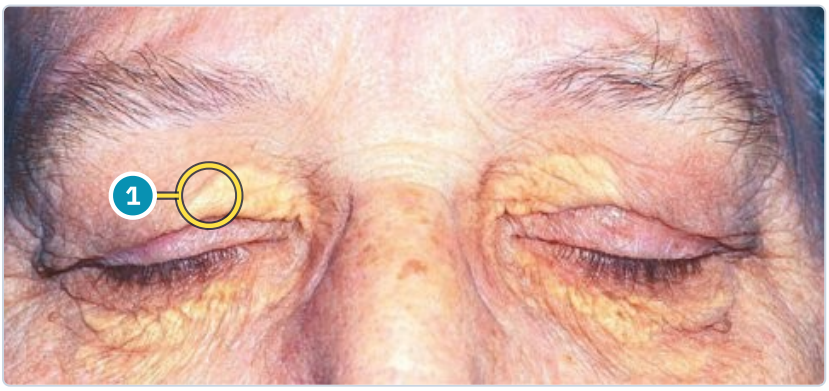


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 120

QUÉ TIENES QUE VER

1 Placa amarilla palpebral

DIAGNÓSTICO

Xantelasmas

Placas amarillas en los párpados: obligan a medir el colesterol.

CONDUCTA INICIAL

Perfil lipídico y riesgo cardiovascular.

1.02.1.007 **Dislipidemias**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Siringomas: pápulas del color de la piel.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 98
Tema 5.4

Clase 5.4 en video

19 TEMA 5.4 · DISLIPIDEMIAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., Fig. 135-4

QUÉ TIENES QUE VER

1 Engrosamiento nodular del tendón de Aquiles

DIAGNÓSTICO

Xantoma tendinoso del Aquiles

Específico de hipercolesterolemia familiar.

CONDUCTA INICIAL

LDL > 190 + xantomas + infartos precoces en la familia: hipercolesterolemia familiar.

1.02.1.007 **Dislipidemias**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Tendinitis aquiliana: dolorosa y sin LDL alto.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 98
Tema 5.4

Clase 5.4 en video

20 TEMA 5.5 · DISLIPIDEMIAS SEVERAS Y GENÉTICAS

OTRA (AGENTE O VECTOR)

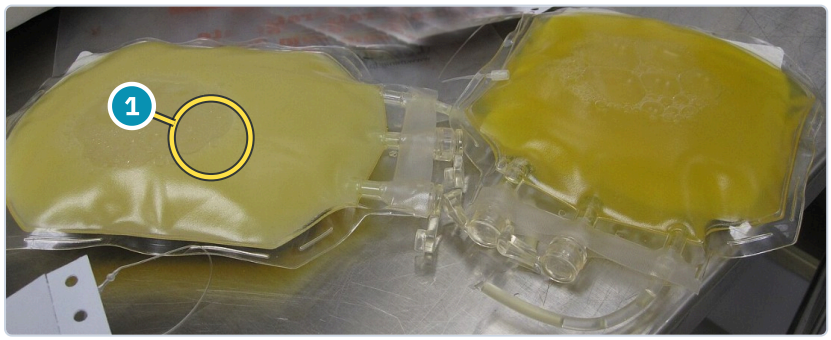


Imagen: Wikimedia Commons «Lipemic plasma.jpg», CC BY-SA 3.0, DiverDave

QUÉ TIENES QUE VER

1 Plasma blanquecino

DIAGNÓSTICO

Plasma lipémico

Plasma lechoso por exceso de triglicéridos.

CONDUCTA INICIAL

TG > 500: fibrato de urgencia por riesgo de pancreatitis; cero alcohol.

1.02.2.005 **Hipertrigliceridemia grave**

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hemólisis: plasma rojo.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P77** «Un paciente de 45 años, obeso (con IMC:35) y diabético, en tratamiento con metformina y empaglifozina y con antecedente de consumo de 4 cervezas…» → **Iniciar dieta estricta**

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 102
Tema 5.5

Clase 5.5 en video

21 TEMA 5.5 · DISLIPIDEMIAS SEVERAS Y GENÉTICAS

FOTO CLÍNICA

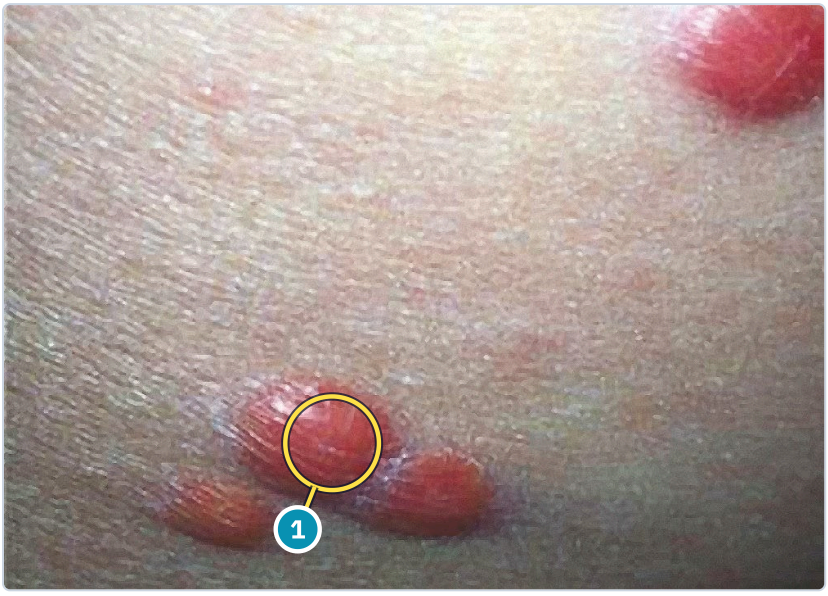


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 26

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pápula amarillenta con halo rojo

DIAGNÓSTICO

Xantomas eruptivos

Pápulas amarillentas con halo rojo que aparecen de golpe con TG muy altos.

CONDUCTA INICIAL

TG > 1.000: fibrato inmediato y dieta casi sin grasa.

1.02.2.005 Hipertrigliceridemia grave

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Foliculitis: pústula centrada en un vello.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS **p. 102** Tema 5.5

Clase 5.5 en video

22 TEMA 5.5 · DISLIPIDEMIAS SEVERAS Y GENÉTICAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Talley & O'Connor, Clinical Examination, p. 116

QUÉ TIENES QUE VER

1 Anillo grisáceo en el borde de la córnea

DIAGNÓSTICO

Arco corneal

Anillo grisáceo en la periferia de la córnea; prematuro antes de los 45 años.

CONDUCTA INICIAL

En joven, estudiar hipercolesterolemia familiar (LDL > 190).

1.02.1.007 Dislipidemias

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Arco senil del adulto mayor: sin valor patológico.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS **p. 102** Tema 5.5

Clase 5.5 en video

23 TEMA 5.6 · NUTRICIÓN CLÍNICA

ESQUEMA

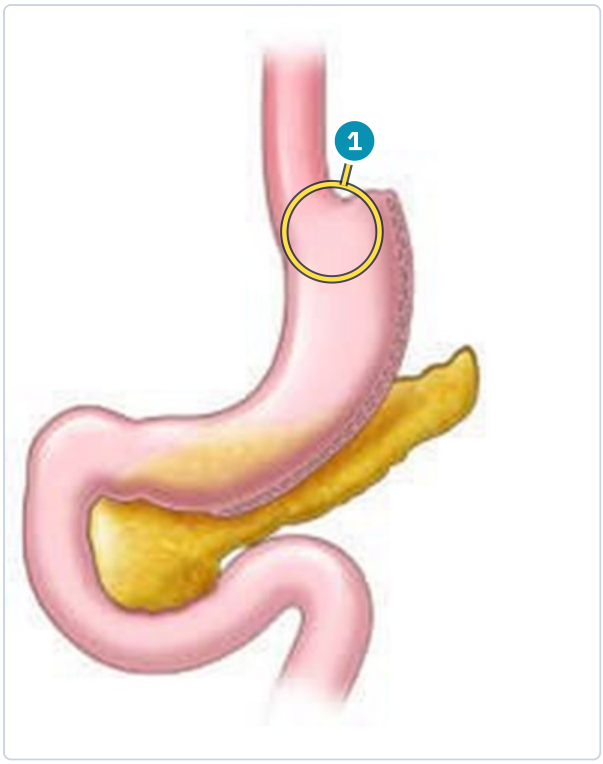


Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 402-3 (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Estómago tubular remanente

DIAGNÓSTICO

Manga gástrica

Se reseca gran parte del estómago y queda un tubo angosto.

CONDUCTA INICIAL

Obesidad mórbida: la DM2 remite en 60-80%.

1.02.1.013 **Obesidad mórbida**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Bypass en Y de Roux: restrictivo y malabsortivo.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 105
Tema 5.6

Clase 5.6 en video

24 TEMA 5.6 · NUTRICIÓN CLÍNICA

FOTO CLÍNICA



Imagen: High-Yield review, p. 774

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pliegues oscuros y engrosados del cuello

DIAGNÓSTICO

Acantosis nigricans (síndrome metabólico)

Hiperpigmentación aterciopelada del cuello: marcador de resistencia a la insulina.

CONDUCTA INICIAL

Síndrome metabólico: 3 de 5 criterios; estilo de vida y tratar cada componente.

1.02.1.016 **Síndrome metabólico**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

1.02.1.012 **Obesidad**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Dermatitis por suciedad: se quita al lavar.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P42 «Un paciente de 30 años, con IMC: 30 Kg/m2 consulta por hoperpigmentación de la piel de las axilas y el cuello, asociado a aparición de...» → **Resistencia a la insulina**

TOMO DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
p. 106
Tema 5.6

Clase 5.6 en video

Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Úlcera neuropática vs isquémica



VS



A Úlcera neuropática (mal perforante plantar)

- Zona de apoyo
- Callo alrededor, indolora

Ficha n.° 14 · p. 10

B Úlcera isquémica distal

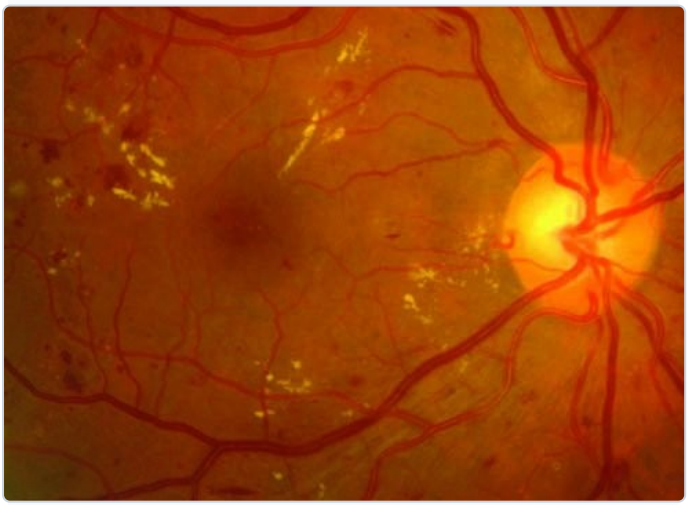
- Punta del dedo
- Lecho pálido, sin callo

Ficha n.° 15 · p. 11

LA DIFERENCIA La neuropática se descarga; la isquémica obliga a estudiar la irrigación.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

No proliferativa vs proliferativa



VS



A Retinopatía diabética: microaneurismas

- Microaneurismas y exudados

Ficha n.° 09 · p. 8

B Retinopatía proliferativa: neovasos en la papila

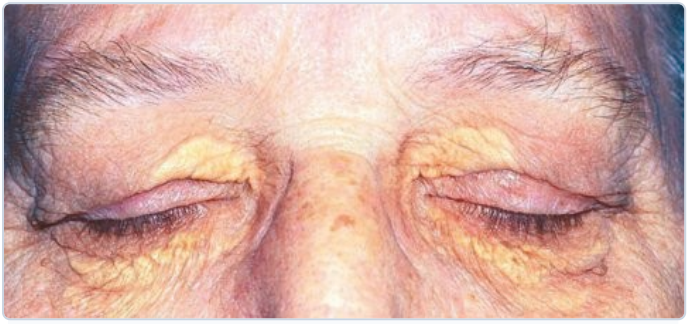
- Neovasos en la papila

Ficha n.° 11 · p. 9

LA DIFERENCIA Solo los neovasos definen la proliferativa: panfotocoagulación.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Xantelasma vs xantoma tendinoso



VS



A Xantelasmas

- Párpados
- Puede tener colesterol normal

Ficha n.° 18 · p. 12

B Xantoma tendinoso del Aquiles

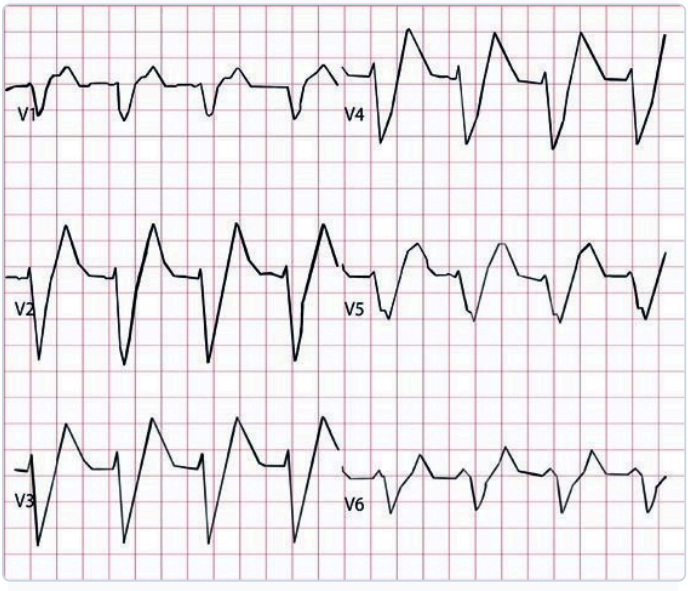
- Tendón de Aquiles
- Hipercolesterolemia familiar

Ficha n.° 19 · p. 13

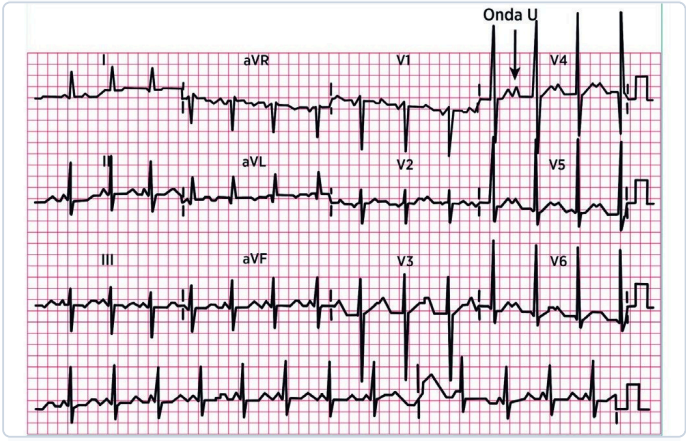
LA DIFERENCIA El xantoma tendinoso sí es específico.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Hiperkalemia vs hipokalemia



VS



A Hiperkalemia en la cetoacidosis: T picudas

- T picudas

Ficha n.° 06 · p. 6

B Hipokalemia en la cetoacidosis: onda U

- Onda U

Ficha n.° 05 · p. 5

LA DIFERENCIA En la cetoacidosis el potasio decide cuándo iniciar la insulina.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.



ACANTOSIS NIGRICANS

Piel oscura y aterciopelada en cuello, axilas y pliegues.

Se ve en: Resistencia a la insulina.

Tomo p. 6 · Atlas: ficha n.° 01, p. 3

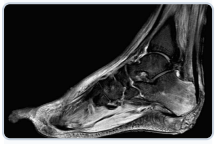


MAL PERFORANTE PLANTAR

Úlcera indolora en zona de apoyo con rodete de callo.

Se ve en: Neuropatía diabética.

Tomo p. 92 · Atlas: ficha n.° 14, p. 10



PRUEBA DEL ESTILETE ÓSEO

Tocar hueso con un estilete a través de la úlcera.

Se ve en: Osteomielitis (Wagner 3).

Tomo p. 91 · Atlas: ficha n.° 16, p. 11



XANTOMAS ERUPTIVOS

Pápulas amarillas con halo rojo.

Se ve en: Hipertrigliceridemia grave.

Tomo p. 102 · Atlas: ficha n.° 21, p. 14



KIMMELSTIEL-WILSON

Glomeruloesclerosis nodular.

Se ve en: Nefropatía diabética.

Tomo p. 84 · Atlas: ficha n.° 07, p. 7

Índice por tipo de imagen

12	2	1	3	2	4
FOTO CLÍNICA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	OTRA (AGENTE O VECTOR)	TRAZADO (ECG / REGISTRO)	FONDO DE OJO

Foto clínica · 12

01 Acantosis nigricans en el cuello (1.1) 3
02 Acantosis nigricans axilar (1.2) 3
03 Candidiasis vulvovaginal (2.3) 4
04 Lipohipertrofia por insulina (3.1) 4
12 Pie neuropático con dedos en garra (5.3) 9
14 Úlcera neuropática (mal perforante plantar) (5.3) 10
15 Úlcera isquémica distal (5.3) 11
18 Xantelasmas (5.4) 12
19 Xantoma tendinoso del Aquiles (5.4) 13
21 Xantomas eruptivos (5.5) 14
22 Arco corneal (5.5) 14
24 Acantosis nigricans (síndrome metabólico) (5.6) 15

Esquema · 2

07 Glomeruloesclerosis nodular (Kimmelstiel-Wilson) (5.1) 7
23 Manga gástrica (5.6) 15

Imagen radiológica · 1

16 Osteomielitis en resonancia (5.3) 11

Otra (agente o vector) · 3

13 Monofilamento de 10 g (5.3) 10
17 Índice tobillo-brazo (5.3) 12
20 Plasma lipémico (5.5) 13

Trazado (ECG / registro) · 2

05 Hipokalemia en la cetoacidosis: onda U (4.3) 5
06 Hiperkalemia en la cetoacidosis: T picudas (4.3) 6

Fondo de ojo · 4

08 Hemorragias en punto y exudados duros (5.2) 7
09 Retinopatía diabética: microaneurismas (5.2) 8
10 Exudados algodonosos y hemorragias (5.2) 8
11 Retinopatía proliferativa: neovasos en la papila (5.2) 9

Autoevaluación

11 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

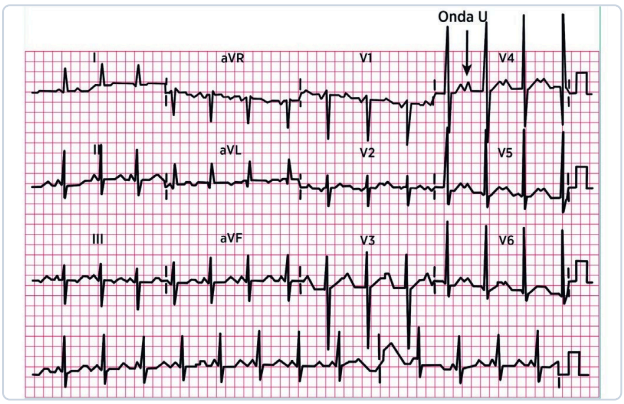
1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



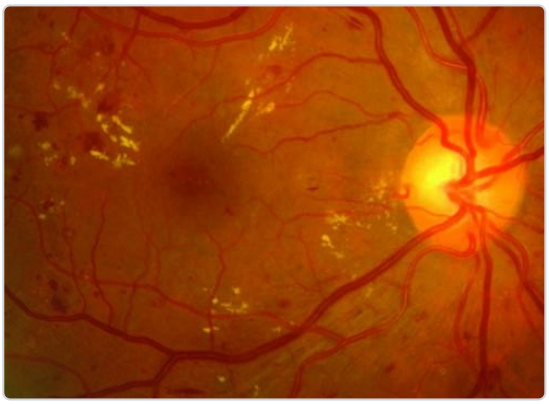
2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



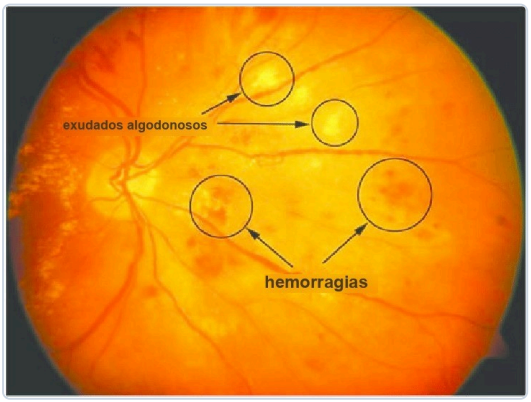
3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



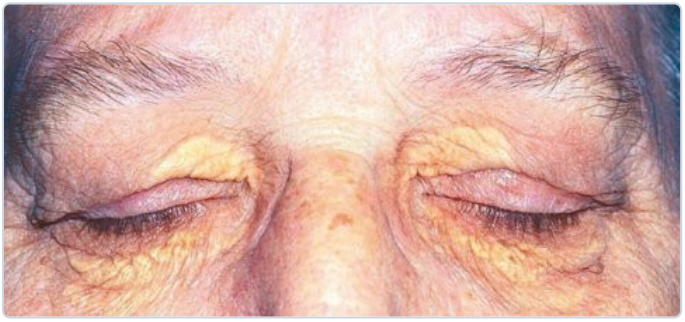
7 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



8 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



9 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



10 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



11 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Acantosis nigricans en el cuello**	Pliegues hiperpigmentados y aterciopelados	01 · p. 3
2	**Lipohipertrofia por insulina**	Abultamiento en el sitio de inyección	04 · p. 4
3	**Hipokalemia en la cetoacidosis: onda U**	Onda U (flecha)	05 · p. 5
4	**Retinopatía diabética: microaneurismas**	Microaneurismas	09 · p. 8
5	**Exudados algodonosos y hemorragias**	Exudados algodonosos	10 · p. 8
6	**Retinopatía proliferativa: neovasos en la papila**	Neovasos en abanico	11 · p. 9
7	**Úlcera neuropática (mal perforante plantar)**	Lecho de la úlcera	14 · p. 10
8	**Úlcera isquémica distal**	Necrosis en la punta del dedo	15 · p. 11
9	**Xantelasmas**	Placa amarilla palpebral	18 · p. 12
10	**Xantoma tendinoso del Aquiles**	Engrosamiento nodular del tendón de Aquiles	19 · p. 13
11	**Xantomas eruptivos**	Pápula amarillenta con halo rojo	21 · p. 14